

LA DELIVRANCE NORMALE

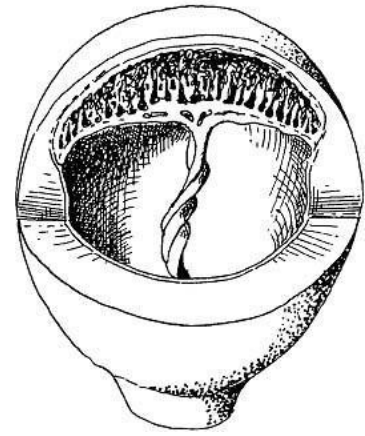
Objectifs:

- Connaître les différentes phases de délivrance
- Connaître les facteurs favorisant des complications
- Prise en charge de la complication de la délivrance.

I. INTRODUCTION :

LA DELIVRANCE = 3^{ème} phase du travail

- L'expulsion des annexes fœtales hors des voies génitales
- Trois phases
 - **Décollement**
 - **Migration**
 - **Expulsion**
- On distingue
 - **Normale : Spontanée ou Naturelle**
 - **Dirigée**
 - **artificielle**
- C'est une étape critique
 - Surveillance particulière
- Complications
 - Mortalité maternelle importante par hémorragie
 - Morbidité non négligeable



II. PHYSIOLOGIE :

A. Phase de décollement placentaire :

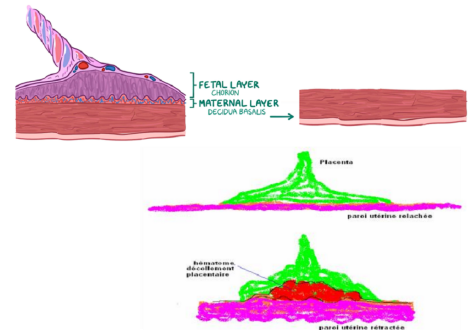
1- Rétraction utérine :

- = Phénomène passif : ↓ du volume utérin + ↑ épaisseur du myomètre
⇒ **ENCHATONNEMENT PHYSIOLOGIQUE** du placenta.
- Cliniquement :
 - Phase de rémission clinique
 - Phase de repos physiologique
 - Durée 10 à 15 mn

2- Contractions utérines :

- Ressenties, douloureuses ⇒ Décollement du placenta
- Clivage complet entre caduque utérine e
- La couche profonde de la muqueuse utérine

C'est l'hématome retro placentaire PHYSIOLOGIQUE



B. Phase de migration :

- Vers le segment inférieur ⇒ **Dépassement du segment inférieur** et **Refoulement de l'utérus**.
- Types de migration :
 - **Mode de Baudelocque** : Face fœtale
⇒ **Insertion haute et FUNDIQUE**.
 - **Mode de Duncan** : voir la face maternelle après l'expulsion ⇒ **Insertion du type PREAVIA**.



C. Phase d'expulsion :

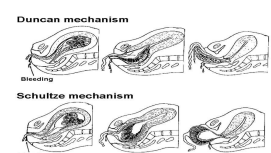
- A travers la vulve : **Spontanée, ou Naturelle**.

D. Hémostase :

- Deux facteurs : ++++++
 - **Facteurs mécaniques** : = Ligature vivante des artères spiralées
 - **Facteurs vasculaires** : **Thrombose des vaisseaux**
 - × Par augmentation facteurs coagulation +++
 - × Par diminution des inhibiteurs de la coagulation comme l'antithrombine III
 - × Richesse du placenta en thromboplastines procoagulantes libérées lors du décollement

Si déficit en facteurs de la coagulation : ⇒ Hémorragie de la délivrance

Placental separation methods



III. MODALITES DE LA DELIVRANCE :

A. Délivrance normale :

1- Spontanée :

- AUCUNE intervention.
- Délivrance est LENTE
- Expulsion se fait :
 - Par le poids du placenta
 - Par le poids de l'HRP
 - Par les contractions utérines.

2- Naturelle :

- ! PREFEREE / délivrance normale ⇒ Accélère l'expulsion
- Surtout respecter la phase de rémission
- Technique : = gestes simples :
 - Une main met le cordon ombilical sous LEGERE tension
 - Une autre main déplisse le segment inférieur ⇒ S'assurer du décollement ++++
 - Puis elle EMPAUME le fond utérin
 - Puis elle exerce une manœuvre de REFOULEMENT

SURTOUT PAS D'EXPRESSIONS

B. Délivrance dirigée : = Délivrance assistée +++

1- Intérêt :

- Raccourcir la période de la délivrance
- Renforce la contraction utérine dès l'expulsion fœtale.

2- Modalités :

- Ocytocine :
 - En perfusion
 - En injection IM de 5 UI

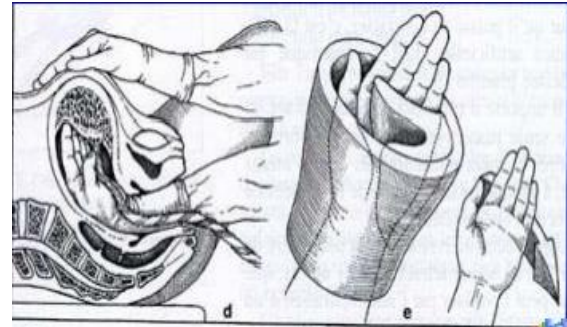
Dès le dégagement l'épaule antérieure

3- Bénéfices :

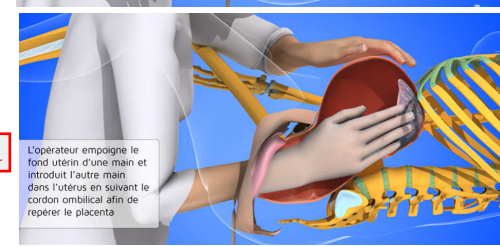
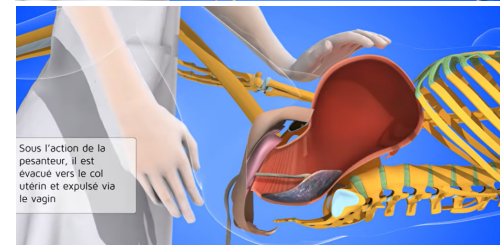
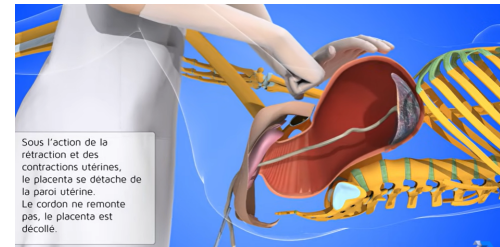
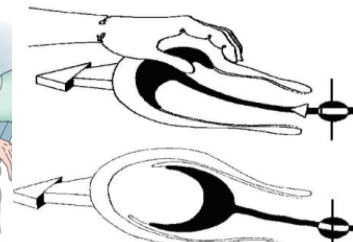
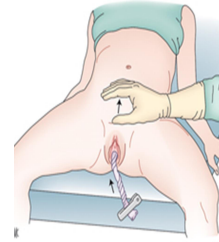
- Trois fois moins d'hémorragies de la délivrance.
- Raccourcissement du délai de la délivrance.
- Diminution du nombre de DA et de RU.

4 - Indication ++

C. DELIVRANCE ARTIFICIELLE



Type de délivrance	Mécanisme	Intervention	Délai	Risques principaux
Normale (spontanée)	Décollement + expulsion naturels	Aucune	< 30 min	Peu
Dirigée	Décollement spontané, expulsion aidée	Utérotonique + expression douce	< 10-15 min	Inversion si mauvaise technique
Artificielle	Décollement et expulsion manuels	Intervention manuelle sous anesthésie	> 30 min ou urgence	Infection, hémorragie



IV. SURVEILLANCE CLINIQUE :

A. Délivrance : ++++

- Faire très attention
- 2 heures en SALLE d'accouchement ++
- 24 heures après accouchement.

1- Phase de rémission : = Phase de détente maternelle : patiente calme.

⇒ Surveillance :

- Pouls ; TA ; Utérus est rétracté jusqu'à l'ombilic, globuleux, ferme
- Vulve : Peu de liquide amniotique
- PRESQUE PAS de saignement +++
- Durée 10 à 15 mn, MAXIMUM 20 mn

⇒ NE RIEN FAIRE

2- Phase de décollement et de migration :

- Contractions réapparaissent
- Saignement minime à travers la vulve
- Signes du décollement
 - Allongement de la portion extériorisée du cordon.
 - Ascension du fond utérin en sus ombilical.
 - Manœuvre de mobilisation de l'utérus vers le haut :
 - ✗ Cordon ne remonte pas avec l'utérus => placenta décolle.

= Décollement est fait

⇒ Surveillance :

- Pouls ; TA
- Saignement
- L'utérus

3- Phase d'expulsion :

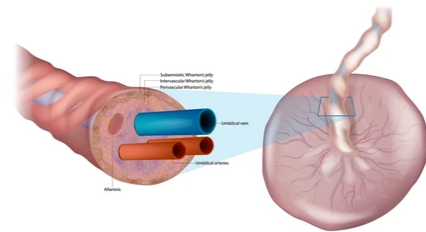
- Saignement ne doit pas dépasser 500 cc

4- Contrôle d'une bonne rétraction :

- Garantie par :
 - Globe utérin de sécurité.
 - Fond utérin au-dessus de l'ombilic
 - Expression : absence d'issue de sang *Arrêt de saignement par la vulve.

B. Examen du délivre : minutieux

- **Face fœtale :**
 - Insertion du cordon, habituellement centrale
 - Composition du cordon (2 artères et 1 veine).
- **Face maternelle :**
 - Cotylédons : rouge vifs, brillants, lisses réguliers
 - Intégralité du délivre (cotylédons manquants)



shutterstock.com - 2218037997

A RETENIR :

CE QU'IL FAUT FAIRE	CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE
Patienter pdt 30 mn	Tirer sur le cordon
Respecter la physiologie	Expression sur le fond utérin
Surveiller le saignement	Négliger les membranes
Privilégier la délivrance dirigée	ABANDONNER la femme

LA DELVRANCE PATHOLOGIQUE

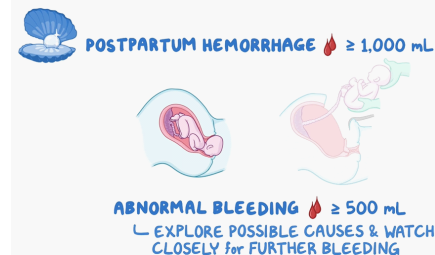
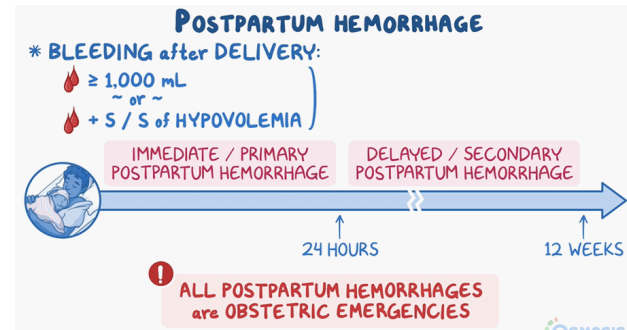
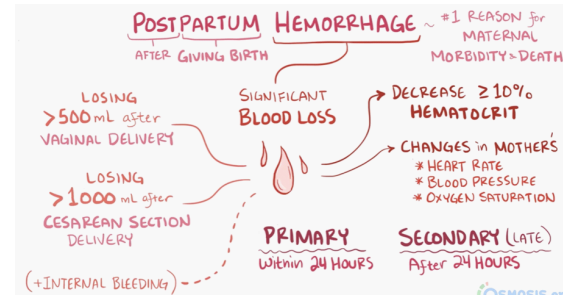
Recouvre 3 entités cliniques :

- 1 – Rétentions placentaires
- 2 – Inversion utérine
- 3 – Hémorragie du post partum

HEMORRAGIE DU POST PARTUM

I. INTRODUCTION

- Autrefois appelé
 - Hémorragie de la délivrance mais
- Définition internationale
 - >500 cc dans les 24 H après accouchement
 - HPP modérées volume compris entre 500 et 1 000 ml
 - HPP sévères s'il est supérieur à 1 000 ml.
- Attention :
 - Chute de tension tardive
 - Parfois hémorragie masquée
 - Difficulté de quantification
- Première cause de mortalité au Maroc
- Mais évitable
- Complicue $\cong$ 10 à 20 % des accouchements
- Hémorragie est :
 - Brutale et FOUDROYANTE
 - Lente et DISTILENTE
 - Interne et CACHEE
- Meilleure prise en charge passe par un Diagnostic PRECOCE
 - $\Rightarrow$ Recherche des situations à risque
 - $\Rightarrow$ Surveillance du travail + accouchement



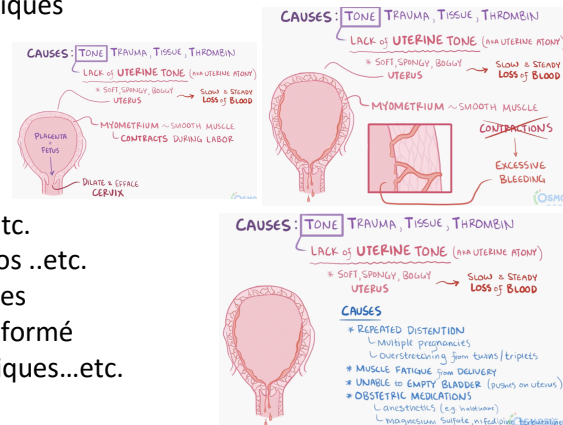
II. FREQUENCE :

- OMS : 500 000 décès maternel par AN
- Au MAROC :
 - 228 / 100 000 naissances $\Rightarrow$ 25 % = Hémorragie de la délivrance.
 - 140 / 100 000 naissance $\Rightarrow$ 3 – 4 femmes décèdent par jour
- En France : = 2ème cause de mortalité maternelle $\Rightarrow$ 20 % des cas
- USA : $\Rightarrow$ 30 % des décès maternels

III. FACTEURS FAVORISANTS : Ces facteurs sont assez souvent intriqués

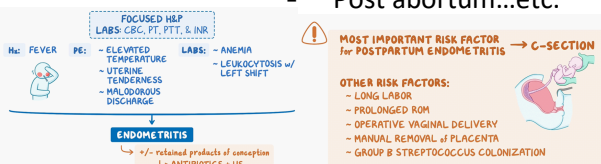
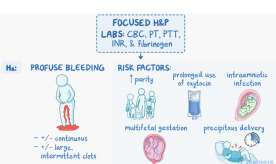
A. Anomalie de la fonction contractile et rétractile du muscle utérin :

- Elle entraîne:
 - Un retard à la délivrance (supérieure à 30 minutes),
 - Souvent une rétention placentaire
- Les facteurs favorisants sont multiples :
 - Épuisement musculaire: travail prolongé; travail rapide...etc.
 - Surdistension utérine grossesses multiples, de l'hydramnios ..etc.
 - Dégénérescence fibreuse du myomètre: grandes multipares
 - Diminution de la contractilité : utérus fibromateux ou malformé
 - Interférences médicamenteuses: β mimétiques, anesthésiques...etc.



B. Altérations de la muqueuse utérine :

- Post infectieuse:
 - Chorioamniotite,
 - Endométrite post partum,
 - Post abortum...etc.
- Post-traumatique:
 - Curetage, aspiration endo-utérine, révision utérine...etc.
 - Chirurgie endo-utérine
 - Césarienne segmentaire ou corporéale

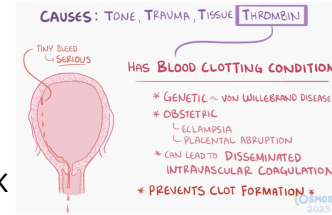
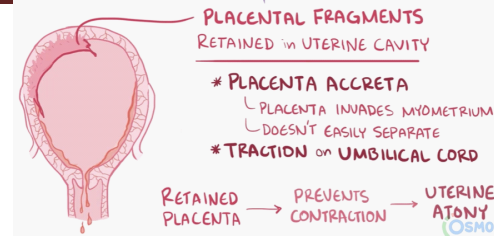
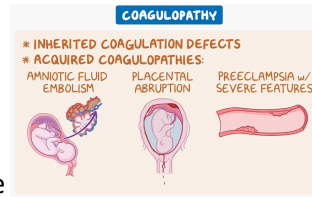


C. Anomalies placentaires :

- De taille : Volume placentaire
- De forme : Placenta bilobé, cotylédons aberrants...etc.
- D'insertion : Placenta prævia

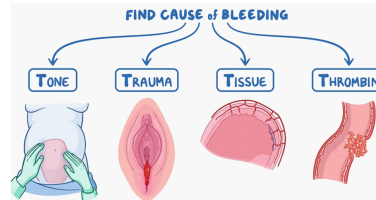
D. Anomalies de la coagulation:

- Pathologie préexistante congénitale
- Pathologie induite par la grossesse :
 - HELLP syndrome
 - Stéatose hépatique aiguë gravidique
- Modification de la coagulation induite par un traitement :
 - Héparines de BPM
 - Héparine standard
- CIVD de l'hématome rétro placentaire et de l'embolie amniotique

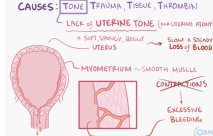
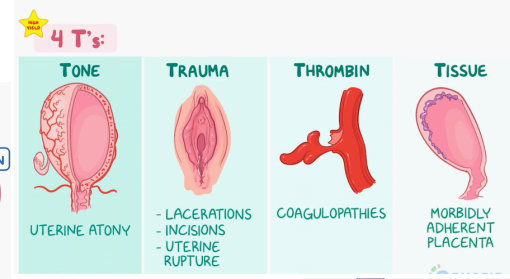


E. Fautes techniques :

- Tentative d'extraire prématurément un placenta encore non décollé
 - Traction sur le cordon,
 - Expression utérine,
- Interventions obstétricales difficiles.
 - Plaies cervico-vaginales
 - Utérines
 - Episiotomie



POSTPARTUM HEMORRHAGE



IV. ETIOLOGIES :

A. Causes utérines : (90 % des cas)

1- Atonie utérine : $\cong 58\%$ = Inertie utérine = Anomalie de la contractilité du myomètre.

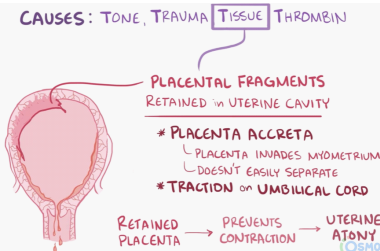
- Patiente avec facteurs de risque +++
- Cliniquement : Absence de globe de sécurité
- Soit elle est secondaire à :
 - Un cotylédon manquant,
 - Un cotylédon aberrant;
 - Une rétention de membranes
- Soit elle est primitive
 - ATCD d'hémorragies de la délivrance
 - Multiparité, Surdistension utérine
 - HRP, placenta prævia.

Processus étiologique	Facteurs de risque cliniques
Anomalies des contractions utérines (Cause)	Polyhydramnios, Grossesse multiple, macrosomie
Surdistension utérine	Travail rapide, Travail prolongé, Grande multiparité
Épuisement musculaire utérin	Placenta prævia, Rupture de membranes prolongée
Infection intra-utérine	

2- Rétention placentaire : 29 %

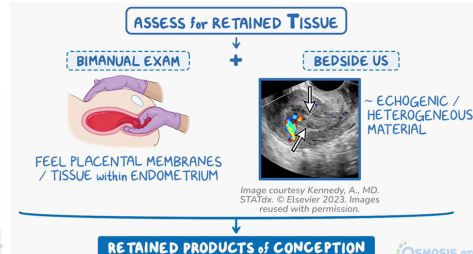
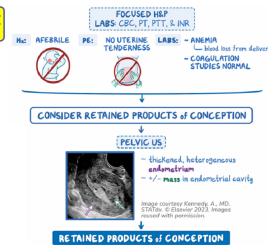
a. Rétention placentaire totale : 3 – 5 % = Absence de délivrance après 20 à 30 mn.

- Par :
 - Absence de décollement
 - Obstacle à la migration :
 - Distension vésicale
 - Incarcération : Segment inférieur.
 - Enchâtonnement : Corne utérine.
 - Placenta acréta



b. Rétention placentaire partielle : $\cong 25\%$

- Cotylédon manquant
- Cotylédon aberrant
- Rétention des membranes



3- Rupture utérine : $\cong 2\%$

- Rupture utérine spontanée :
 - Sur utérus cicatriciel
 - Sur utérus sain
- Rupture utérine iatrogène après :
 - Une manœuvre obstétricale
 - Une manœuvre instrumentale
 - Utilisation intempestive d'ocytociques
- Gravité variable :
 - Simple déhiscence de cicatrice
 - Rupture sous péritonéale
 - Rupture complexe



4- Placenta acréta : $\cong 2 \%$

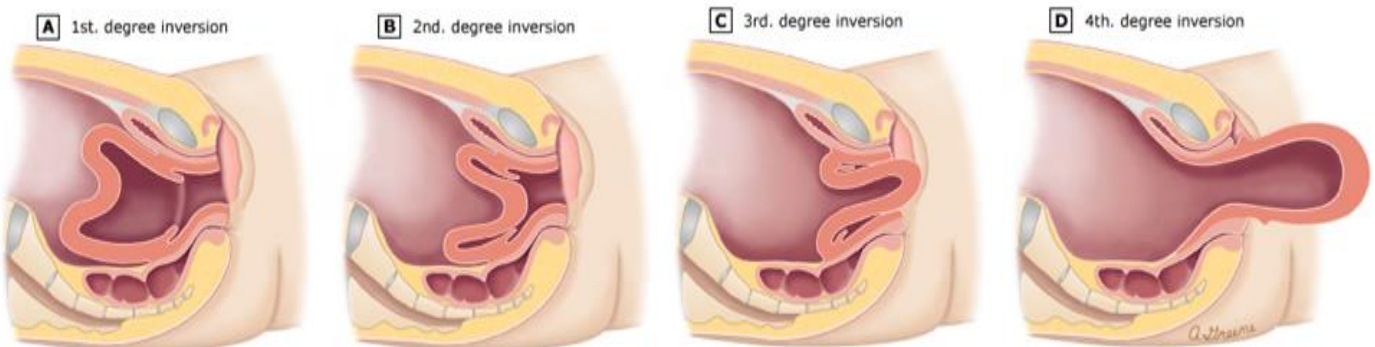
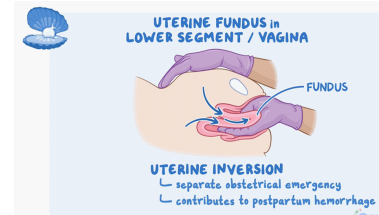
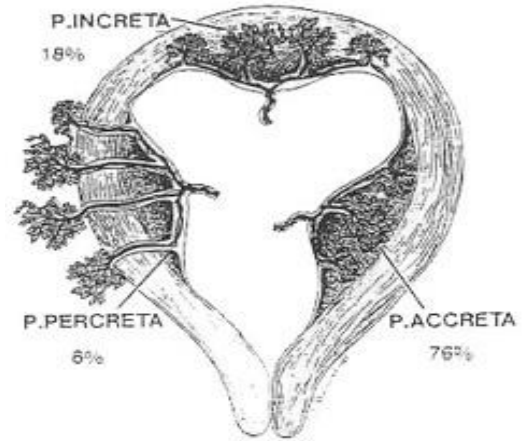
= Envahissement du myomètre par le placenta

- **Plusieurs types :**
 - Placenta acréta
 - Placenta percréta
 - Placenta incréta
 - Placenta destruens

- Cliniquement :
= Délivrance IMPOSSIBLE

5- Inversion utérine : $< 1\%$

- Retournement en doigt de gant +/- complète du fond utérin
- Soit immédiatement après la délivrance ou parfois après $\Rightarrow$ Diagnostic retardée
- **Cliniquement :**
 - Douleurs pelviennes atroces
 - Hémorragie parfois importante
 - Cupule au niveau du fond utérin
 - Utérus parfois extériorisé.



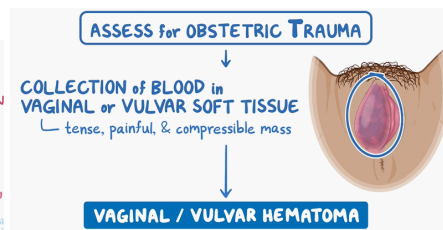
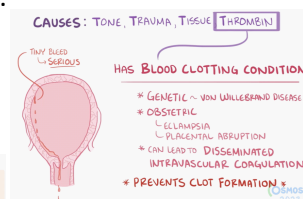
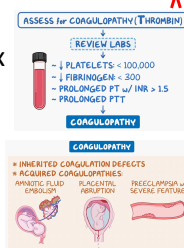
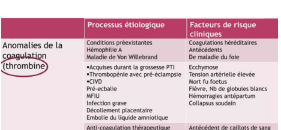
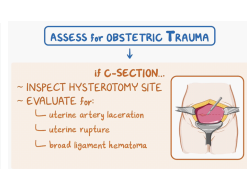
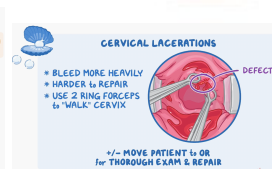
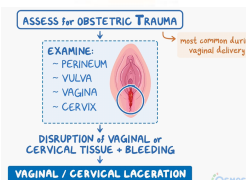
B. Traumatismes de la filière génitale : 4 – 8 %

- Un accouchement dystocique,
- Une manœuvre instrumentale

C. Coagulopathie : $\approx 1 - 3\%$

- Constitutionnelle : maladie de Willebrand, PTI...
- Acquisée : ASSESS for COAGULOPATHY (THROMBIN)

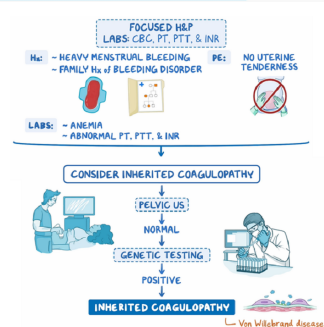
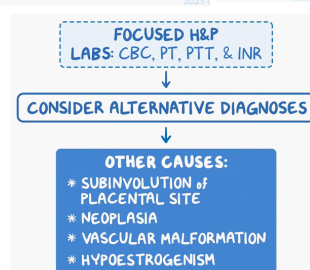
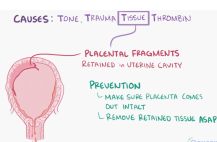
- Syndromes vasculo-rénaux
- Mort fœtale in utero
- HRP
- Embolie amniotique ...etc



V. PRISE EN CHARGE :

A. Prévention : meilleur traitement

- Délivrance dirigée SYSTEMATIQUE;
- OBLIGATOIRE si facteurs de risque
- SURVEILLANCE rapprochée du post partum
- **Et autres mesures :**
 - Prévention de l'anémie
 - Supplémentation ferrique à partir du 2ème trimestre
 - Dépistage et prise en charge des grossesses à risque au cours de la consultation prénatale.
 - Respect de la physiologie de la délivrance.
 - Délivrance dirigée systématique.
 - Délivrance artificielle OBLIGATOIRE après 30 minutes d'attente.
 - Examen systématique et minutieux du placenta et des annexes



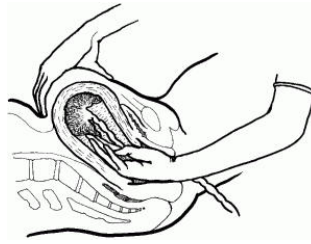
B. Traitement :

1- Moyens thérapeutiques :

a. Obstétricaux :

❖ Délivrance artificielle : = Extraction manuelle du placenta

- **Conditions :**
 - ASEPSIE RIGOREUSE ++++
 - De préférence anesthésie locorégionale
 - Couverture antibiotique
- **Technique:** voir chapitre précédent
- **Terminer par une révision utérine**
- **Assurer vacuité utérine et l'intégrité utérine**



❖ Révision utérine :

- Mêmes conditions que la délivrance artificielle
- Obligatoire devant toute hémorragie de la délivrance
- Vider l'utérus
- S'assurer de l'absence de rétention placentaire ou membranes
- Vérifier l'intégrité de l'utérus

❖ Massage utérin :

- Couplé à l'utilisation d'utérotoniques
- Assure la bonne rétraction utérine
- mouvements circulaires fermes exercés sur le fond et le corps de l'utérus
- Une main enserme le fond utérin le
- PLUS LONGTEMPS POSSIBLE



b. Médicaux :

❖ Mesures de réanimation :

- Contrôle de la TA et remplissage.
- Oxygénothérapie ++++
 - Si pertes sanguines IMPORTANTES :
 - × Réanimation INTENSIVE
 - × Transfusion de CG ; PFC , concentrés des PQ ...etc.

❖ Utérotoniques (Ocytociques):

- **Ocytocine :**
 - **Utilisés par voie :**
 - × Intraveineuse : 10 – 20 UI (IVD , ou perfusion)
 - × Intramyométriale : 10 – 20 UI
 - × Intramusculaire : 10 – 20 UI
 - **N'est pas ni souhaitable ni utile de dépasser 60 à 80 UI**
 - × Non efficace au del de ces doses
 - × Effets secondaires => intoxication a l'eau
- **Prostaglandines :** = Utérotoniques puissants +++
 - **Voies d'utilisation :**
 - × Voie locale, orale , intra-rectale
 - × Voie IV à la pompe +++
 - × Voie IM
 - × **La voie IVD est contre indiquée**

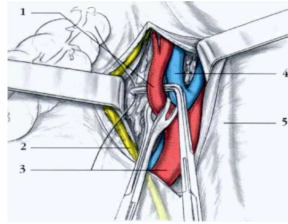
• Plusieurs types

❖ Autres

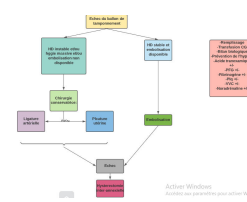
- **Dérivés de l'ergot de seigle :(Methylergométrine)**
 - × Voie IM , ou intra murale , Cps , gouttes
 - × Effets secondaires : cardio-vasculaires
- **Contre-indications :**
 - × HTA
 - × Cardiopathie

c. Chirurgicaux :

- Examen sous valves : obligatoire
⇒ Suture des lésions cervico-vaginales
- Suture des lésions utérines si rupture
- Ligature des artères hypogastriques
- Embolisation des artères utérines
- Hystérectomie d'hémostase



Technique de B-Lynch



2- Indications :

a. Dans tous les cas :

1 - Évaluer les fonctions vitales

2 - Libérer les voies aériennes ⇒ Donner l'oxygène

3 - Mise en condition : Bonne voie veineuse

⇒ Prélèvements

⇒ Remplissage en fonction de la TA

⇒ Transfusions

4 - Position de la patiente : ⇒ Tête BASSE

5- Révision utérine

6- Examen sous valves

- Bilan biologique / 2 à 3 heures jusqu'à arrêt du saignement

8 - Traiter la cause

b. Rétention placentaire totale : DA + RU+ utérotoniques

c. Rétention placentaire partielle : RU + utérotoniques

d. Inertie utérine :

- RU + utérotoniques + Massage utérin
- ± Ligature des artères hypogastriques
- ± Embolisation des artères hypogastriques
- +/- hystérectomie en dernier recours

e. Rupture utérine : laparotomie

- Suture des lésions
- Si non hystérectomie

f. Placenta accréta :

- DA + RU+ Utérotoniques
- Souvent ligature vasculaire et hystérectomie

g. Inversion utérine :

- Réduction manuelle ou chirurgicale
- Rarement hystérectomie d'hémostase

h. Lésions cervico vaginales :

- Suture sous valves et sous sédation

i. Troubles de l'hémostase :

- Réanimation intensive +++
- Transfusion + facteurs de la coagulation

VI. CONCLUSION :

- HPP complication redoutable
- Diagnostic précoce
 - = prise en charge rapide
 - = bon pronostic
- Diagnostic tardif
 - = prise en charge lourde
 - = pronostic réservé

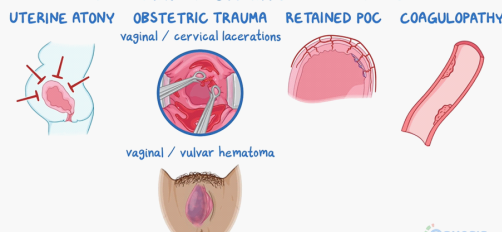
POSTPARTUM HEMORRHAGE

LIFE-THREATENING COMPLICATION of CHILDBIRTH

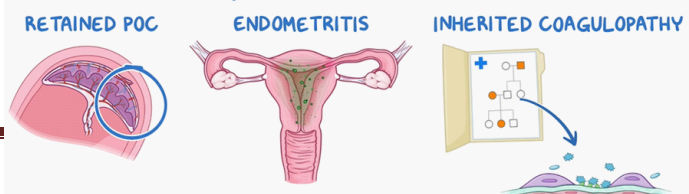


STABILIZE PATIENT → LOOK for CAUSE

IMMEDIATE POSTPARTUM HEMORRHAGE



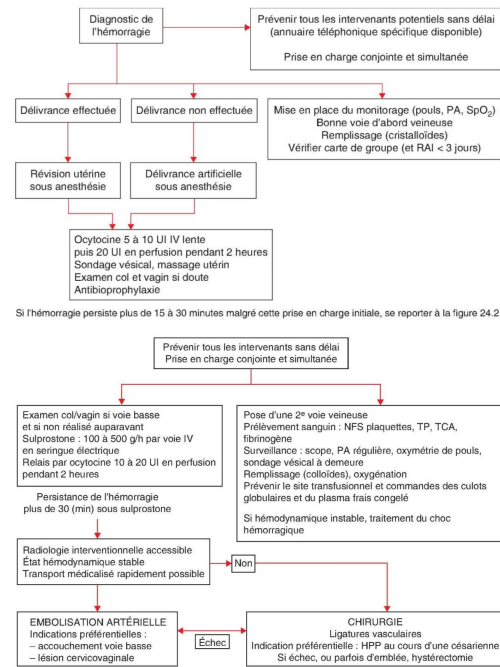
DELAYED POSTPARTUM HEMORRHAGE



Complications



Fig. 22.2. Prise en charge d'une hémorragie du post-partum immédiat qui persiste au-delà de 15 à 30 minutes.



POSTPARTUM HEMORRHAGE

* MOST COMMON CAUSE ⇒ MATERNAL MORBIDITY & MORTALITY

